Diagnóstico em Psiquiatria

Nov 12, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

Como fechar cada diagnóstico das 13 aulas: o critério central, o tempo mínimo, o achado que separa um quadro do vizinho e casos clínicos curtos com a resposta. Sem medicamentos.

Régua dos tempos

O tempo é o critério que mais separa quadros parecidos. Em questão de caso clínico, procure primeiro há quanto tempo os sintomas existem.

Tempo	Diagnóstico	Detalhe que cai
Minutos, pico em minutos	Ataque de pânico	Dura cerca de 40 minutos a 1 hora
4 dias	Hipomania	Sem internação, sem psicose, sem prejuízo grave
7 dias	Mania	Ou qualquer duração se precisar internar
2 semanas	Episódio depressivo maior	5 sintomas, 1 obrigatório
2 semanas	Psicose sem humor no esquizoafetivo	O que separa do humor com psicose
Menos de 1 mês	Transtorno psicótico breve	Remissão completa
1 mês	Critério A da esquizofrenia; transtorno delirante; pânico (apreensão após um ataque)	
1 vez por semana por 3 meses	Bulimia e compulsão alimentar	
Até 3 meses do estressor	Início do transtorno de adaptação	
Últimos 3 meses	Subtipo da anorexia (restritivo ou purgativo)	O diagnóstico alimentar segue os últimos 3 meses
1 a menos de 6 meses	Transtorno esquizofreniforme	

Tempo	Diagnóstico	Detalhe que cai
6 meses	Esquizofrenia, TAG, agorafobia, fobia específica, ansiedade de doença	
Até 6 meses após o fim do estressor	Limite do transtorno de adaptação	
6 meses (criança) ou 12 meses (adulto)	Luto prolongado	Após a morte
Mais de 1 ano, início antes dos 18	Tourette e tique persistente	
2 anos, sem passar mais de 2 meses bem	Distimia e ciclotimia	
Início antes dos 5 anos	Transtorno de apego reativo	
4 ou mais episódios em 12 meses	Ciclagem rápida no bipolar	

Aulas 1 e 2. Achados do exame do estado mental

O EEM (exame do estado mental) dá as pistas que apontam para um grupo de doenças. Estes achados mudam a hipótese:

Achado	Aponta para
Atenção prejudicada, confusão que **flutua** e piora à noite	Delirium: causa orgânica, emergência
Desorientação no tempo e no espaço (alopsíquica)	Causa orgânica (delirium, demência)
Não sabe quem é (autopsíquica)	Quadro psiquiátrico primário
Age no automático e não lembra depois (amnésia lacunar)	Estado crepuscular: zolpidem, blackout, epilepsia, TCE
Hipotenaz e hipovigil, lentidão global	Depressão grave
Hipertenaz e hipervigil, aceleração	Mania
Fuga de ideias (troca de tema com ligação)	Mania

Achado	Aponta para
Afrouxamento, descarrilhamento, desagregação, neologismo, bloqueio	Esquizofrenia
Afeto embotado	Esquizofrenia grave e psicoses crônicas
Delírio de influência, pensamento roubado, "todos ouvem o que penso"	Esquizofrenia (consciência e limite do eu)
Alucinação auditiva "de fora", com o paciente descrevendo as vozes	Psicose
Alucinação visual pouco ligada ao delírio	Investigar causa neurológica
Alucinação com crítica ("sei que não é real")	Alucinose: orgânico (abstinência alcoólica, Charles Bonnet)
Alucinação olfativa sem psicose	Aura e quadros neurológicos
Confabulação	Demência, Korsakoff
Pensamento mágico com rituais	TOC
Ato repetido para aliviar ansiedade	Compulsão (TOC); se busca prazer imediato, impulso
Mutismo, estupor, catalepsia, negativismo, ecos	Catatonia
Perda súbita do tônus ao rir, consciente	Cataplexia: narcolepsia

Pares que confundem

- **Alerta x lúcido:** acordado e responde x pensa com clareza. O delirante pode estar alerta e não lúcido.
- **Ideia sobrevalorada x delírio:** há um fato real exagerado x certeza impossível de mudar.
- **Alucinação x ilusão x alucinose:** sem objeto e sem crítica x objeto real distorcido (casaco vira pessoa) x sem objeto e com crítica.
- **Alucinação verdadeira x pseudoalucinação:** "ouço no ouvido, vem de fora" x "ouço dentro da cabeça".
- **Cataplexia x catalepsia:** cai sem tônus x fica rígido na pose.

Casos

1. **Idosa internada com infecção urinária fica agitada à noite, não reconhece a filha e vê "gente no quarto"; de manhã está melhor.** Resposta: delirium. Pistas: flutuação, piora noturna, atenção prejudicada e causa orgânica.
2. **Homem em abstinência alcoólica ouve vozes falando dele na terceira pessoa e diz "sei que não tem ninguém falando".** Resposta: alucinose alcoólica. Pista: a crítica está preservada.
3. **Paciente acorda sem lembrar que comeu e mandou mensagens de madrugada após tomar zolpidem.** Resposta: estado crepuscular com amnésia lacunar.

Aula 3. Transtornos depressivos

Diagnóstico	Critério central	Tempo	O que o separa
TDM (transtorno depressivo maior)	5 ou mais sintomas, sendo 1 obrigatório: humor deprimido ou anedonia	2 semanas	Episódio intenso e delimitado
Distimia (depressivo persistente)	Humor deprimido mais 2 sintomas (apetite, sono, energia, autoestima, concentração, desesperança)	2 anos, sem mais de 2 meses bem	Crônico e menos intenso
TDPM (disfórico pré-menstrual)	5 sintomas, pelo menos 1 afetivo (labilidade, irritabilidade, tristeza, ansiedade)	Na maioria dos ciclos, de 1 semana antes a 1 semana depois da menstruação	Ligado ao ciclo

Sintomas do TDM: humor deprimido, anedonia, peso ou apetite, sono, agitação ou lentidão observável por terceiros, fadiga, culpa ou inutilidade, concentração, pensamentos de morte. Gancho: "SIGECAPS" (Sono, Interesse, Culpa, Energia, Concentração, Apetite, Psicomotor, Suicídio).

Gravidade: leve, faz o que é obrigatório com mais esforço; grave, deixa de fazer o que precisa.

Diferenciais que caem:

- **Luto x depressão:** luto intenso por pouco tempo é esperado; prejuízo grande por mais de cerca de 2 semanas pede investigação de TDM ou luto prolongado (este exige 12 meses no adulto).

- **Depressão unipolar x bipolar:** 12,5% a 30% dos "deprimidos" são bipolares. Sempre pergunte por episódios de energia alta e pouca necessidade de sono no passado.
- **Depressão x transtorno de adaptação com humor deprimido:** na adaptação há estressor claro e os critérios de TDM não se completam.
- **Depressão x TAG:** avaliar os critérios de cada um separadamente; se nenhum se completa, misto ansioso e depressivo.

Perfil inflamatório: lentidão, queixa cognitiva, amotivação grave, ansiedade e PCR maior que 3.

Quando rastrear: depressão prévia ou na família, adversidade na infância, doença crônica, periparto ou perimenopausa, dor crônica, sintomas físicos sem explicação, insônia, uso de substâncias, quem usa muito o serviço de saúde.

Casos

1. **Mulher de 28 anos há 3 semanas sem prazer em nada, dorme mal, perdeu 4 kg, sente culpa e não consegue trabalhar.** Resposta: TDM grave. Pistas: mais de 2 semanas, anedonia obrigatória, 5 ou mais sintomas e prejuízo importante.
2. **Homem que há 3 anos "vive para baixo", com baixa autoestima e cansaço, mas trabalha; nunca ficou mais de um mês bem.** Resposta: distimia. Pistas: 2 anos ou mais, intensidade menor e nunca 2 meses sem sintomas.
3. **Jovem com irritabilidade intensa, choro, inchaço e dor nas mamas na semana anterior à menstruação, que somem alguns dias depois, quase todo mês.** Resposta: TDPM. Pista: relação com o ciclo e 1 sintoma afetivo.
4. **Paciente "deprimido" que conta ter passado uma semana, há 1 ano, dormindo 3 horas por noite, cheio de planos e gastando muito.** Resposta: não é depressão unipolar; é TAB tipo I (houve mania).

Aulas 4 e 5. Bipolar e risco de suicídio

Os episódios

Episódio	Tempo	Gravidade que define
Mania	7 dias, ou qualquer duração se internar	Prejuízo grave, internação **ou psicose**
Hipomania	4 dias seguidos	Mudança perceptível, sem prejuízo grave, sem internação, sem psicose

Episódio	Tempo	Gravidade que define
Depressão maior	2 semanas	Mesmos critérios do TDM

Sintomas maniformes: humor elevado, expansivo ou irritável com aumento de energia, mais 3 sintomas (4 se o humor for só irritável): grandiosidade, menos necessidade de sono, fala acelerada, fuga de ideias, distraibilidade, mais atividade ou agitação, gastos e sexo de risco.

Regra de ouro: se houver psicose ou internação, é mania, nunca hipomania.

Os diagnósticos

Diagnóstico	O que exige
TAB tipo I	1 mania na vida (depressão não é obrigatória)
TAB tipo II	1 hipomania e 1 depressão maior, nunca mania
Ciclotimia	2 anos de oscilações que não completam hipomania nem depressão, sem passar mais de 2 meses bem
Ciclagem rápida (especificador)	4 ou mais episódios em 12 meses
Episódio misto	Sintomas dos dois polos ao mesmo tempo: corpo sem energia, mente acelerada

Dica de anamnese: pergunte por energia, atividade e produtividade, não só por humor.

Diferenciais

Pista	TAB	Borderline	TDAH
Duração da mudança	Dias a semanas	Horas	Breve
Curso	Episódios com períodos bem	Crônico, reativo	Contínuo desde a infância
Gatilho	Pode não haver	Conflito, medo de abandono	Estímulos do ambiente
Sono	Precisa de menos e acorda bem	Não é critério	Demora a dormir, mas precisa dormir

Pista	TAB	Borderline	TDAH
Autoimagem e relações	Não são centrais	Instáveis, idealiza e desvaloriza	Não são centrais

Avaliação do risco de suicídio

Escada de gravidade: ideação de morte (passiva), ideação suicida (ativa), desejo, intenção, planejamento (método, hora e lugar definidos), tentativa e suicídio.

Risco alto: intenção persistente, plano estruturado, desesperança, tentativa prévia (sobretudo planejada), frustração por não ter morrido, estado misto, recusa ao tratamento, história familiar, falta de suporte e acesso a arma. **Proteção:** filhos, religião, vínculos e projetos de vida.

Dados que caem: homens consumam mais e mulheres tentam mais; 90% têm transtorno mental; TDM lidera em número absoluto e TAB no risco individual; no TAB a letalidade é maior no tipo II.

Casos

1. **Mulher de 24 anos há 10 dias dorme 3 horas por noite, sem cansaço, fala sem parar e fez dívidas de R$ 20 mil. Teve depressão aos 19.** Resposta: episódio maníaco, TAB tipo I. Pistas: mais de 7 dias, menos sono sem cansaço e prejuízo grave.
2. **Homem com 5 dias de energia alta e produtividade acima do normal, notados pela esposa, sem prejuízo no trabalho; antes teve depressão de 1 mês.** Resposta: TAB tipo II. Pistas: hipomania (4 dias, sem prejuízo grave) com depressão prévia.
3. **Paciente bipolar que, há 2 semanas, não tem energia para sair da cama, mas tem pensamentos acelerados e agitação interna.** Resposta: episódio depressivo com características mistas, de maior risco de suicídio.
4. **Mulher que muda de humor várias vezes no mesmo dia após brigas com o namorado, com medo de ser deixada e cortes nos braços.** Resposta: borderline, não bipolar. Pistas: horas, gatilho de abandono e automutilação.

Aula 6. Transtornos psicóticos

Os 5 domínios: delírio, alucinação, pensamento desorganizado, comportamento desorganizado ou catatônico e sintomas negativos (afeto diminuído, avolição, associabilidade, alogia, anedonia, pensamento concreto, prejuízo cognitivo).

Esquizofrenia

- **A.** 2 ou mais domínios por 1 mês, com **pelo menos 1 nuclear**: delírio, alucinação ou pensamento desorganizado.
- **B.** Queda do funcionamento em relação ao **próprio nível anterior** (trabalho, relações, autocuidado). O paciente não volta a ser quem era, por causa dos sintomas negativos.
- **C. 6 meses** de sinais contínuos, incluindo fases residuais.

Personalidade pré-mórbida: esquizoide (pior prognóstico), esquizotípica (maior risco de evoluir), sensitiva (forma paranoide) e bem adaptada (melhor prognóstico). **Pior prognóstico:** psicose longa sem tratamento, início precoce, perfil esquizoide.

Como separar os quadros

Quadro	Tempo	Achado que define
Psicótico breve	Menos de 1 mês	Remissão completa
Esquizofreniforme	1 a menos de 6 meses	Quadro de esquizofrenia sem o tempo
Esquizofrenia	6 meses ou mais	Queda global do funcionamento
Transtorno delirante	Delírio por 1 mês ou mais	**Nunca preencheu o critério A**; só o delírio; funciona bem fora do tema; comportamento não bizarro
Esquizoafetivo	Longitudinal	Episódio de humor com psicose **mais 2 semanas de psicose sem humor**
Humor com sintomas psicóticos	Dentro do episódio	A psicose só existe junto com a depressão ou a mania

Delírio bizarro x não bizarro: implausível na cultura x possível, embora improvável (ser perseguido pelo vizinho). O persecutório é o mais comum.

Catatonia: na depressão tem mais negativismo e não tem flexibilidade cérea, que pode ocorrer na esquizofrenia.

Psicose orgânica: desconfie quando a alucinação é visual e não combina com o delírio, ou quando os sintomas aparecem só durante o uso de estimulantes.

Casos

1. **Homem de 22 anos há 8 meses ouve vozes que comentam seus atos, acredita que implantaram um chip, largou a faculdade e não toma banho.** Resposta: esquizofrenia. Pistas: mais de 6 meses, alucinação e delírio, queda de funcionamento e sintomas negativos.
2. **Mesmo quadro, mas com 3 meses de evolução.** Resposta: esquizofreniforme.
3. **Mulher de 30 anos que, após a morte súbita do pai, passa 10 dias desorganizada e com delírio, e volta ao normal.** Resposta: psicótico breve.
4. **Mulher de 55 anos convencida há 2 anos de que a vizinha a envenena; evita o mercado quando acha que ela estará lá, mas trabalha, cozinha e se cuida.** Resposta: transtorno delirante. Pista: prejuízo restrito ao tema do delírio.
5. **Paciente com mania psicótica no passado que, sem alteração de humor, mantém vozes por 1 mês.** Resposta: esquizoafetivo tipo bipolar. Pista: psicose sozinha por mais de 2 semanas.
6. **Deprimida grave que acredita estar falida e que os órgãos apodreceram; os delírios somem quando a depressão melhora.** Resposta: depressão com sintomas psicóticos. Pista: a psicose nunca aparece fora do episódio.

Aula 7. Transtornos de ansiedade

A chave é perguntar: do que exatamente o paciente tem medo? Todos têm preocupação como base; muda o foco.

Diagnóstico	Foco do medo	Tempo	Achado que define
TAG (ansiedade generalizada)	Vários temas da vida	6 meses, maioria dos dias	Preocupação difícil de controlar mais 3 sintomas: tensão, irritabilidade, concentração, fadiga, inquietação, sono
Transtorno de pânico	O próximo ataque	1 mês após um ataque	Ataques **inesperados** e recorrentes, com apreensão ou mudança de comportamento
Agorafobia	Não conseguir escapar ou receber ajuda	6 meses	2 de 5 situações: aberto, transporte, fechado, fila ou multidão, sair sozinho

Diagnóstico	Foco do medo	Tempo	Achado que define
Ansiedade social	Ser avaliado negativamente		Interação, observação (comer em público) ou desempenho (falar em público)
Fobia específica	Um objeto ou situação	6 meses	Animal, ambiente natural, sangue e injeção, situacional, outro
Ansiedade de separação	Afastar-se da figura de apego		Mais comum na infância
Mutismo seletivo	Falar em certos ambientes		Fala preservada em outros
Induzido por substância			Ex.: cafeína

O ataque de pânico

- Início abrupto, **pico em minutos**, **4 ou mais** de 14 sintomas (palpitação, dor no peito, falta de ar, asfixia, náusea, tontura, sudorese, calafrio, tremor, formigamento, desrealização, despersonalização, medo de enlouquecer, medo de morrer).
- Dura cerca de 40 minutos a 1 hora; o que sobra depois é ativação residual.
- **Menos de 4 sintomas** ou sem desespero intenso: crise de ansiedade, não ataque de pânico.
- Ataque de pânico sozinho não é transtorno de pânico: pode ocorrer em outros quadros (especificador).
- **Exclua causa orgânica:** angina e infarto, asma e embolia, infecção, hipo ou hiperglicemia, intoxicação (cafeína, drogas), abstinência de álcool e benzodiazepínico.

Diferenciais que caem

- **Medo x ansiedade:** ameaça presente x antecipação do futuro.
- **Ansiedade x agitação:** preocupação x inquietação motora com pensamento acelerado e pressão para falar (mania).
- **Pânico x agorafobia:** no pânico o medo é do ataque; na agorafobia, do lugar de onde não se escapa. Podem coexistir.
- **Agorafobia no idoso:** verificar se o medo não é de queda real ou limitação física.
- **Ansiedade social x evitativo:** a social é restrita a situações de avaliação; no evitativo a inadequação atinge quase toda a vida.

Casos

1. **Mulher de 35 anos que há 1 ano se preocupa com dinheiro, saúde dos filhos e trabalho, com tensão no pescoço, cansaço e insônia.** Resposta: TAG. Pistas: vários temas, mais de 6 meses e 3 sintomas.
2. **Homem de 28 anos com dois episódios súbitos de taquicardia, falta de ar e medo de morrer, ECG normal, que há 2 meses evita dirigir com medo de ter outro.** Resposta: transtorno de pânico. Pistas: ataques inesperados e mais de 1 mês de esquiva.
3. **Mulher que há 8 meses não anda de ônibus nem vai ao shopping sozinha, com medo de passar mal e não ter como sair.** Resposta: agorafobia.
4. **Estudante que trava ao apresentar trabalhos e evita comer no refeitório por medo de ser julgado.** Resposta: ansiedade social.
5. **Paciente que desmaia ao ver sangue e evita exames há anos.** Resposta: fobia específica do tipo sangue, injeção e ferimentos (resposta vasovagal).

Aula 8. TOC e espectro

TOC

- **A.** Obsessões, compulsões ou ambas. Obsessão: pensamento, impulso ou imagem intrusiva, repetida e **egodistônica** (contrária aos valores), que o paciente reconhece como da própria mente. Compulsão: ato ou pensamento repetido, com regras rígidas, para aliviar a ansiedade ou evitar algo temido.
- **B.** Consome tempo ou causa sofrimento ou prejuízo. **Se deixar de fazer o ritual não incomoda, não é TOC.**
- **C.** Não é efeito de substância (sintomas só durante uso de estimulante não são TOC).
- **D.** Não é mais bem explicado por psicose, ansiedade ou humor.
- **Especificar insight:** bom, pobre ou ausente com crença delirante.

Padrões: contaminação com lavagem; dúvida com verificação; pensamentos agressivos, sexuais ou religiosos com rituais mentais; simetria com lentidão.

Dados de prova: começa mais cedo em meninos; 25% até os 14 anos; início após os 35 é incomum e pede diferenciais. Obsessões sexuais ou religiosas aumentam o risco de suicídio.

Pares que confundem

- **Pensamento intrusivo normal x obsessão:** todos têm pensamentos intrusivos e os descartam; no TOC eles ganham importância e geram ritual.
- **Compulsão x impulso:** alivia ansiedade x busca prazer.

- **Obsessão x delírio:** a obsessão é egodistônica e reconhecida como exagerada; no insight ausente ela se aproxima do delírio.
- **TOC x TOC de personalidade:** no TOC há obsessões e rituais; na personalidade obsessivo compulsiva há perfeccionismo, rigidez e controle como jeito de ser (Aula 11).
- **TOC x ansiedade de doença:** existe TOC de tema hipocondríaco, com intrusivos e checagens sobre saúde.

Espectro

Diagnóstico	Achado central	Diferença que cai
Dismórfico corporal	Defeito na aparência imperceptível aos outros, com espelho, comparação e checagem	**Não é sobre peso ou gordura** (isso é transtorno alimentar); dismorfia muscular é uma forma
Acumulação	Não consegue descartar; ambientes inutilizados	Insight geralmente ausente; acima de 55 anos, diferenciar de demência; surge aos 15 a 19, interfere aos 20, prejuízo aos 30
Tricotilomania	Arranca cabelo, com falhas, e tenta parar	Movida por impulso e hábito, não por obsessão; insight preservado; mais comum no TDAH (15,3%)
Escoriação	Cutuca a pele com lesões e tenta parar	Excluir escabiose, dermatose e delírio de Ekbom
Tourette	Vários tiques motores e pelo menos 1 vocal	Mais de 1 ano, início antes dos 18; começa aos 4 a 6 anos, pico aos 10 a 12
Tique motor ou vocal persistente	Só motor ou só vocal	Mais de 1 ano, início antes dos 18

Casos

1. **Mulher que lava as mãos 40 vezes por dia por medo de contaminar os filhos, sabe que é exagero e chora se não lava.** Resposta: TOC de contaminação com bom insight.
2. **Homem que volta 5 vezes para conferir se trancou a porta e chega atrasado ao trabalho.** Resposta: TOC de dúvida com verificação.

3. **Jovem que passa horas no espelho por causa de um nariz que todos acham normal.** Resposta: transtorno dismórfico corporal (não é anorexia, pois não é sobre peso).
4. **Criança de 11 anos que pisca, faz caretas e solta grunhidos há 2 anos.** Resposta: Tourette.

Aula 9. Trauma e estressores

Neste grupo o estressor é critério diagnóstico. A pergunta-chave é: qual foi o evento e quão grave ele foi?

TEPT (transtorno de estresse pós-traumático)

Gancho: **"1, 1, 1, 2, 2"**.

1. **Exposição** a morte real ou ameaçada, lesão grave ou violência sexual: vivida, testemunhada, ocorrida de forma violenta com alguém próximo ou por exposição repetida a detalhes (socorristas, policiais).
2. **1 ou mais intrusivos:** lembranças involuntárias, pesadelos, flashbacks (mais graves), sofrimento ou reação física diante de gatilhos.
3. **1 ou 2 formas de esquiva:** de lembranças e sentimentos, ou de lugares, pessoas e situações.
4. **2 ou mais de humor e cognição:** amnésia de partes do evento, emoção negativa persistente, crenças negativas sobre si e o mundo, culpa distorcida, desinteresse, incapacidade de sentir emoção positiva.
5. **2 ou mais de hiper-reatividade:** irritabilidade, imprudência, hipervigilância, sobressalto, concentração ruim, sono ruim.

Estresse agudo prévio aumenta o risco, mas não é obrigatório. **Fatores de risco:** adversidade na infância, transtorno prévio, pouca resiliência, falta de apoio, sexo feminino, juventude e evento mais grave.

Como separar os quadros

Diagnóstico	O que define
TEPT	Evento grave mais os 4 grupos de sintomas completos
Resposta persistente ao trauma	Sintomas relevantes, mas sem completar o TEPT ("TEPT parcial")

Diagnóstico	O que define
TEPT complexo (CID-11, não está no DSM)	Trauma prolongado e sem fuga (tortura, violência doméstica crônica, abuso repetido na infância) mais desregulação emocional, autoimagem negativa e prejuízo nas relações
Transtorno de adaptação	Estressor comum, sintomas em até **3 meses**, sofrimento desproporcional ou prejuízo, somem em até **6 meses** após o fim do estressor; não é luto normal nem outro transtorno
Luto prolongado	Morte de pessoa próxima há **12 meses** (adulto) ou 6 (criança); saudade ou preocupação intensa mais 3 de 8 sintomas; excede as normas culturais
Apego reativo	Criança negligenciada, retraída, que não busca conforto; início antes dos 5 anos; excluir TEA
Interação social desinibida	Criança negligenciada que vai com estranhos sem hesitar; não é TDAH

Especificadores da adaptação: com humor deprimido, com ansiedade, misto, com perturbação da conduta, misto de emoções e conduta. **Duração:** agudo (menos de 6 meses) ou persistente (6 meses ou mais, com o estressor ainda presente).

Sintomas do luto prolongado: parte de si morreu junto, descrença na morte, evita lembranças, dor emocional intensa, dificuldade de retomar a vida, apatia, vida sem sentido, solidão. **Diferenciais:** TDM e TEPT.

Casos

1. **Motorista que sobreviveu a um acidente com morte há 4 meses tem pesadelos, não dirige, se assusta com buzinas e se culpa.** Resposta: TEPT.
2. **Homem demitido há 2 meses que chora, dorme mal e não procura emprego, sem fechar critérios de TDM.** Resposta: transtorno de adaptação com humor deprimido.
3. **Viúva que, 14 meses após a morte do marido, não acredita que ele morreu, evita a casa e sente que perdeu o sentido da vida.** Resposta: transtorno do luto prolongado.
4. **Criança de 3 anos, institucionalizada, que não procura o cuidador quando se machuca.** Resposta: transtorno de apego reativo.

Aula 10. Somatoformes e dissociativos

Sintoma no corpo sem doença que explique

Duas perguntas resolvem: o paciente produz o sintoma de propósito? Se sim, ganha algo concreto com isso?

Diagnóstico	De propósito?	Ganho externo?	Achado que define
Sintomas somáticos	Não	Não	1 ou mais sintomas com pensamento, ansiedade **ou** tempo excessivos dedicados a eles; busca repetida de exames
Ansiedade de doença	Não	Não	Medo de ter doença grave com sintoma ausente ou mínimo; **6 meses**; subtipo busca ou evitação de cuidado
Conversivo (sintomas neurológicos funcionais)	Não	Não (só ganho secundário inconsciente)	Sintoma motor ou sensorial **incompatível com a neurologia**
Factício (Munchausen)	Sim	Não	Fraude comprovada para ocupar o papel de doente
Simulação (não é transtorno)	Sim	Sim	Dinheiro, afastamento, absolvição

Quando suspeitar de somatização: sintoma sem lógica fisiopatológica, falha terapêutica repetida e prejuízo desproporcional. Lembre que **doença orgânica pode coexistir**.

Conversivo, pontos de prova:

- Exame normal **não** basta: é preciso um achado clínico incompatível com a anatomia (anestesia fora dos dermátomos, fraqueza inconsistente).
- Sintoma "bizarro" também não exclui doença neurológica.
- Catatonia da esquizofrenia ou desmaio só durante pânico **não** são conversão.
- Mais em mulheres jovens; 90% têm outra doença psiquiátrica; 10% têm também epilepsia verdadeira.
- *La belle indifférence* (calma diante de sintoma grave) sugere, mas não é critério.

Crise não epiléptica psicogênica: quadril se movendo, movimentos variáveis, **olhos fortemente fechados**, **grito no meio da crise**, duração longa, pós ictal atípico. Confirmação pelo **vídeo EEG**, com o familiar reconhecendo a crise habitual.

Factício, sinais de suspeita: quadro dramático e incomum, sem resposta ao tratamento, sintomas novos quando outros melhoram, entusiasmo por exames invasivos, recusa a fornecer contatos e prontuários, múltiplas internações e alergias, profissional da saúde, poucas visitas.

Dissociativos

Diagnóstico	Achado que define	Diferencial
Dissociativo de identidade	2 ou mais identidades com lacunas de memória	Não é transe cultural nem crise epiléptica; simulação sugerida por identidades caricatas, orgulho, amnésia conveniente e ganho externo
Amnésia dissociativa	Não recorda informação autobiográfica importante, geralmente traumática; localizada, seletiva ou generalizada	Excluir epilepsia, AVC, AIT, TCE, amnésia global transitória (até 24 horas), álcool, benzodiazepínico, zolpidem, quetamina, sonambulismo
Fuga dissociativa (especificador)	Viagem ou perambulação com amnésia da identidade; diagnóstico retrospectivo	
Despersonalização e desrealização	O eu parece estranho ou o mundo parece irreal, **com juízo de realidade preservado**	Epilepsia focal, intoxicação, excesso de ISRS, ataque de pânico, aura de enxaqueca

Trauma físico x emocional na amnésia: trauma físico agudo (acidente) dá amnésia imediata e restrita; trauma interpessoal grave (agressão sexual) pode dar amnésia tardia, dias depois, com o afeto negativo preservado.

Casos

1. **Mulher de 25 anos com paralisia súbita da perna após briga familiar, reflexos normais e fraqueza que some quando distraída.** Resposta: transtorno conversivo.
2. **Técnica de enfermagem com infecções de repetição sem foco; encontram seringas no quarto; não recebe benefício.** Resposta: transtorno factício.

3. **Homem que finge dor lombar para obter afastamento remunerado.** Resposta: simulação.
4. **Paciente que mede a pressão 10 vezes por dia, sem sintomas, com medo de AVC, há 1 ano.** Resposta: ansiedade de doença, subtipo busca de cuidado.
5. **Motociclista de capacete, sem perda de consciência e com exame neurológico normal, que não lembra do acidente nem das horas antes.** Resposta: amnésia dissociativa localizada.

Aula 11. Transtornos de personalidade

Traço x transtorno: o traço é flexível e se ajusta ao contexto; o transtorno é um padrão **rígido, duradouro e mal adaptativo**, que começa no fim da adolescência ou início da vida adulta e causa prejuízo e sofrimento.

A chave é perguntar o que a pessoa busca ou teme:

Cluster	Transtorno	Núcleo	Achado que separa
A (excêntricos)	Paranoide	Desconfia de todos, guarda rancor	**Sem psicose persistente** (no delirante e na esquizofrenia há)
A	Esquizoide	Isola-se por **desinteresse genuíno**, afeto achatado, indiferente a crítica e elogio	No TEA pode haver desejo de interagir
A	Esquizotípico	Excentricidade, pensamento mágico, ideias de referência sem delírio	Ansiedade social que **persiste mesmo com pessoas conhecidas**; espectro da esquizofrenia
B (dramáticos)	Antissocial	Quer **vantagem**; viola direitos, mente, sem remorso; entende o outro, mas não sente	Não aprende com punição
B	Narcisista	Quer **admiração**; grandioso, autoestima frágil, reage mal à crítica	Busca superioridade, não ganho instrumental
B	Histriônico	Quer **atenção**, mesmo negativa; teatral, sedutor, emoções superficiais	Muda de papel conforme o que dá mais atenção

Cluster	Transtorno	Núcleo	Achado que separa
B	Borderline	Teme **abandono**; instabilidade de humor, autoimagem e relações; idealiza e desvaloriza; vazio; automutilação	Muda em horas, reativo a conflito
C (ansiosos)	Evitativo	Teme **crítica**; sente-se inferior, mas **deseja vínculo**	Ansiedade social ampliada a quase tudo
C	Dependente	Teme **não funcionar sem cuidado**; não decide sozinho, submisso	No borderline o medo é de não ser amado
C	Obsessivo compulsivo	Perfeccionismo, controle, regras, avareza	Não tem obsessões e rituais do TOC

Pares que mais caem:

- **Esquizoide x evitativo:** os dois se isolam; o esquizoide não quer vínculo, o evitativo quer mas tem medo.
- **Narcisista x antissocial:** admiração x vantagem.
- **Histriônico x antissocial:** atenção x vantagem.
- **Borderline x dependente:** medo de não ser amado x medo de não dar conta sozinho.
- **Borderline x TAB:** horas e gatilho x dias a semanas e episódios.

Casos

1. **Homem que não tem amigos nem quer ter, prefere trabalhar sozinho e não liga para elogio ou crítica.** Resposta: esquizoide.
2. **Rapaz que se veste de forma estranha, acredita em telepatia e fica tenso até com colegas que conhece há anos.** Resposta: esquizotípico.
3. **Homem que engana sócios, agride a esposa e diz "ela mereceu", com passagens pela polícia.** Resposta: antissocial.
4. **Mulher que precisa que a mãe escolha suas roupas e decide nada sem perguntar ao marido.** Resposta: dependente.
5. **Jovem tímido que deseja namorar, mas evita qualquer aproximação por medo de ser rejeitado.** Resposta: evitativo.

Aula 12. Transtornos alimentares

O diagnóstico se baseia sempre nos últimos 3 meses, porque o mesmo paciente pode passar de um quadro para outro.

Diagnóstico	Núcleo	Peso	Frequência	Gravidade
Anorexia nervosa	Restrição, medo intenso de engordar, imagem distorcida	Baixo	Subtipo pelos últimos 3 meses	IMC: leve 17 ou mais, moderada 16, grave 15, extrema menos de 15
Anorexia atípica	Todos os critérios, menos o baixo peso	Normal ou alto (era obeso)		Pela restrição e velocidade da perda
Bulimia nervosa	Compulsão mais compensação; autoavaliação presa ao peso	Normal, sobrepeso ou oscilante	1 vez por semana por 3 meses	Compensações por semana: 1 a 3, 4 a 7, 8 a 13, 14 ou mais
Compulsão alimentar	Perda de controle **sem** compensação	Metade não é obesa	1 vez por semana por 3 meses	Episódios por semana: 1 a 3, 4 a 7, 8 a 13, 14 ou mais
Transtorno de purgação	Purga para controlar peso **sem compulsão**			
Síndrome do comer noturno	Come ao acordar de noite ou muito após o jantar, **lembra no dia seguinte**			Diferente do sonambulismo

Pontos de diferenciação

- **Subtipos da anorexia:** restritivo (só restrição, jejum, exercício) ou compulsivo purgativo (compulsão **ou** purgação). A purgação pode ocorrer sem compulsão.
- **Anorexia purgativa x bulimia:** na anorexia o núcleo é "não comer" e o peso é baixo; na bulimia a alimentação entre os episódios é quase normal. A bulimia não pode ocorrer só durante a anorexia.
- **Vômito isolado não define bulimia.**

- **Compulsão x comer hedônico x comer por impulso x hiperfagia:** na compulsão há grande quantidade com **perda de controle**, comer rápido, sem fome, sozinho por vergonha e culpa depois (3 de 5); no hedônico há escolha (comer as emoções); no impulso, "ia comer um brigadeiro e comeu todos"; na hiperfagia, só mais fome.
- **Dismórfico x alimentar:** se a preocupação é com peso e gordura, é alimentar.
- **Sinais de purgação:** banheiro logo após comer, erosão dentária, parótidas aumentadas, hipocalemia; vômito dá alcalose e laxante dá acidose.
- **Achados da anorexia:** amenorreia, osteopenia, anemia, bradicardia, QT longo, constipação, rituais à mesa, interesse por culinária, roupas largas.

Casos

1. **Bailarina de 16 anos, IMC 15,5, amenorreia, se acha gorda e corta a comida em pedaços minúsculos; nunca vomita.** Resposta: anorexia nervosa, tipo restritivo, grave.
2. **Mulher que perdeu 30 kg em 6 meses, com IMC 24, medo intenso de engordar e bradicardia.** Resposta: anorexia atípica.
3. **Universitária de peso normal que, 3 vezes por semana há 5 meses, come grande quantidade escondida e depois vomita.** Resposta: bulimia nervosa leve.
4. **Homem que come muito, rápido e sozinho, sente culpa e não compensa, 2 vezes por semana há 4 meses.** Resposta: compulsão alimentar leve.

Aula 13. Dependências

Padrões de uso

Padrão	O que define	Exemplo
Experimental	Uso pontual, por curiosidade	Usou uma vez numa festa
Recreativo	Em contexto social, por prazer, sem buscar alívio de sofrimento	
Frequente	Regular, sem compulsão nem prejuízo importante	Pede investigar o motivo
Nocivo	Dano pelo **efeito naquele contexto**, independentemente da quantidade	Pouco álcool, dirigiu e bateu o carro
Abusivo	Dano pelo **padrão** de uso ou pela **condição clínica**	Gestante que bebe; cirrótico que continua bebendo
Binge	Muita quantidade em pouco tempo	Comum com álcool

Transtorno por uso: os 11 critérios

1. Usa mais ou por mais tempo que o planejado.
2. Quer ou tenta controlar, sem sucesso.
3. Muito tempo para obter, usar ou se recuperar.
4. Fissura.
5. Falha em obrigações (trabalho, escola, casa).
6. Continua apesar de problemas sociais.
7. Abandona atividades importantes.
8. Usa em situações de risco físico (dirigir, máquinas).
9. Continua apesar de problema físico ou psíquico causado pela substância.
10. Tolerância.
11. Abstinência.

Gravidade: 2 a 3 critérios, leve; 4 a 5, moderada; 6 ou mais, grave. *Gancho: "2, 4, 6".*

Conceitos que caem

- **Intoxicação:** efeito do uso recente; o álcool é bifásico (primeiro euforia, depois sedação).
- **Tolerância:** precisa de mais dose para o mesmo efeito.
- **Abstinência:** sintomas ao reduzir ou parar (irritabilidade, ansiedade, tremor, sudorese, insônia).
- **Fissura:** desejo intenso; maior com meia-vida curta (crack).
- **Reforço positivo x negativo:** no início usa pelo prazer (impulsivo); depois usa para não sofrer com a falta (compulsivo).

Estágio de mudança: identifique pela fala

Fala do paciente	Estágio
"Uso pouco, paro quando quiser"	Pré-contemplação
"Sei que me faz mal, mas não sei se quero parar"	Contemplação (ambivalência)
"Quero começar o tratamento mês que vem"	Preparação
"Parei há 2 semanas e mudei de rotina"	Ação

Fala do paciente	Estágio
"Estou há meses sem usar e evito os gatilhos"	Manutenção
Voltou a usar	Recaída (não é fracasso; costuma voltar à contemplação)
A substância deixou de ser central	Término

Casos

1. **Universitário que bebeu duas latas, dirigiu e causou acidente; não bebe com frequência.** Resposta: uso nocivo.
2. **Gestante que toma uma taça de vinho por dia.** Resposta: uso abusivo (contraindicação clínica).
3. **Homem que bebe mais do que planeja, tentou parar 3 vezes, faltou ao trabalho, precisa de mais álcool para o mesmo efeito e treme pela manhã sem beber.** Resposta: transtorno por uso moderado (5 critérios: mais que o planejado, tentativas de parar, falha em obrigações, tolerância e abstinência).
4. **Paciente que diz "sei que a cocaína está acabando com meu casamento, mas não sei se consigo parar agora".** Resposta: contemplação.

Fonte: apostilas das Aulas 1 a 13 da pasta Psiquiatria (Mariana Freitas, turma 79A), baseadas no DSM-5-TR.